

- (10):1135—1139.
- [2]李艳锋,李苗苗.血府逐瘀汤辅以外用药物治疗黄褐斑并月经不调患者的疗效评价[J].实用临床医药杂志,2020,24(9):87—89.
- [3]林琼.茜草川参汤联合炔诺酮治疗月经不调临床研究[J].四川中医,2021,39(7):162—165.
- [4]陈文静,李伟莉.桃红四物汤治疗妇科疾病的药理作用与临床应用进展[J].安徽中医学院学报,2022,41(2):101—104.
- [5]高艳芳,张佳黎,杨涛,等.低频脉冲电刺激联合桃红四物汤保留灌肠对慢性盆腔炎合并盆腔积液的疗效[J].河北医药,2024,46(2):247—249.
- [6]曹泽毅.中华妇产科学[M].人民卫生出版社,2014.
- [7]杨孝莹,张建伟.叶天士应用“肝-胃”理论辨治月经不调探析[J].山东中医药大学学报,2023,47(6):740—743.
- [8]张燕,覃丽英,莫秋,等.培坤丸联合戊酸雌二醇治疗月经不调的临床研究[J].现代药物与临床,2023,38(6):1418—1422.
- [9]王升菊,刘倩倩,江华娟,等.基于网络药理学和分子对接技术探讨桃红四物汤治疗原发性痛经的有效成分及作用机制[J].中国中药杂志,2020,45(22):5373—5382.
- [10]姜飞.自拟桃红四物汤治疗血瘀型月经不调的临床效果及对内分泌功能的影响[J].妇儿健康导刊,2023,2(17):46—48.

中西医结合治疗消化性溃疡(肝胃不和证)临床疗效观察

陈莎莎

(台州市中医院消化肿瘤科 浙江 台州 318000)

[摘要] 目的:观察消化性溃疡患者采用中西医结合治疗的效果。方法:选取2023年3月—2024年3月期间我院收治的80例消化性溃疡患者,根据不同治疗方式分为常规组(西药治疗)40例和研究组(中西医结合治疗)40例。对比组间临床疗效、中医证候评分、胃肠激素指标。结果:治疗后,研究组的治疗有效率高于常规组($P < 0.05$);研究组的腹痛、嗝气、泛吐酸水、少食、倦怠乏力评分均低于常规组($P < 0.05$)。结论:采用中西医结合治疗消化性溃疡患者的疗效确切,安全性高,对改善临床症状及胃肠激素水平有积极影响,值得推广。

[关键词] 香砂平胃颗粒;消化性溃疡;中医证候积分;胃肠激素水平;治疗效果

中图分类号: R573.3

文献标识码: B

文章编号: 1006-0979(2025)07-0013-03

DOI:10.16040/j.cnki.cn15-1101.2025.07.014

消化性溃疡(PU)主要是由于胃酸及胃蛋白酶的侵蚀作用,导致胃及十二指肠黏膜发生病变,根据侵蚀部位,可分为胃溃疡及十二指肠溃疡,常伴有节律性疼痛及消化不良等症状,严重影响患者的生活质量^[1]。香砂平胃颗粒属于传统中药复方,近年来在临床上应用于消化性溃疡的治疗中备受关注。香砂平胃颗粒是由具有理气和胃、调和脾胃的中药组成,如香附、砂仁、苍术、厚朴等药物^[2]。中医认为,消化性溃疡的发生,初期多为肝胃不和,湿阻中焦,或脾胃虚弱,后期多气滞血瘀,因此,调理脾胃,促进气血运行,可有效缓解溃疡症状,加快溃疡愈合^[3]。现将本实验对香砂平胃颗粒辅助治疗消化性溃疡的研究内容报告如下。

1 资料和方法

1.1 一般资料 选取2023年3月—2024年3月期间台州市中医院收治的80例消化性溃疡患者,根据不同治疗方式分为常规组(西药治疗)40例和研究组(中西医结合治疗)40例。常规组中,男性20例,女性20例,年龄25~65岁,平均年龄(45.36 ± 1.13)岁,病程2~3年,平均病程(2.47 ± 0.87)年,胃溃疡14例,十二指肠溃疡18例,复合溃疡8例;研究组中,男性21例,女性19例,年龄26~66岁,平均年龄(46.18 ± 1.05)岁,病程3~4年,平均

病程(3.78 ± 0.96)年,胃溃疡11例,十二指肠溃疡23例,复合溃疡6例。组间一般资料比较,差异不显著($P > 0.05$)。

入组标准:(1)通过胃镜检查诊断明确是消化性溃疡,符合有关诊断标准;(2)中医参照《中医内科学》^[4]胃脘痛中辨证为肝胃不和证;缺少标引(3)近期没有参加过其他临床研究;(4)病历资料完整;(5) ^{14}C 检查提示幽门螺杆菌感染;(6)患者和家属均知晓实验内容,并签订知情同意书。**排除标准:**(1)存在其他肠胃道病症,或检查结果提示恶性病变;(2)既往有胃肠吻合手术史;(3)合并过敏性病症;(4)无法使用实验药物治疗;(5)由于个人因素中途退出实验。

1.2 治疗方法 两组均进行健康宣教,嘱患者避免进食辛辣刺激性食物。常规组采用四联疗法:阿莫西林胶囊(上海华源安徽仁济制药有限公司;国药准字H34020561;0.25 g)口服,每次0.1 g,一天两次;克拉霉素缓释片(莱阳市江波制药有限责任公司;国药准字H20052746;0.5 g $\times$ 4片/盒)口服,每次0.5 g,一天两次;胶体果胶铋胶囊(浙江得恩德制药股份有限公司;国药准字H20093002;0.1 g)口服,每次0.2 g,一天三次;艾司奥美拉唑镁肠溶片(阿斯利康制药有限公司;国药准字H20046379;20 mg $\times$ 7片)口服,每次20 mg,一天两次。

在常规组的基础上,研究组联合采用香砂平胃颗粒(云南腾药制药股份有限公司;国药准字Z53021652;10 g $\times$ 10袋)治

作者简介:陈莎莎(1993—),女,汉族,中医师,研究生,研究方向:消化肿瘤方向。

疗,口服,每次一袋,一天两次。

两组患者均连续治疗2周。

1.3 观察指标

1.3.1 临床疗效 参照《中医临床病症诊断疗效标准》评估疗效,治愈:临床症状消失,胃镜检查溃疡及炎症反应消失;显效:临床症状明显好转,胃镜检查溃疡消失,但存在轻度炎症反应;有效:临床症状缓解,胃镜检查溃疡面积缩减超过1/2;无效:未达到上述标准甚至加重。

1.3.2 中医证候评分 治疗前后,对泛吐酸水、腹痛、少食、倦怠乏力、嗝气等证候进行评估,每项分值范围0~3分,评分越高越严重。

1.4 统计学分析 数据分析工具使用SPSS25.0软件,计量资料采用($\bar{x} \pm s$)表示,用 t 检验;计数资料采用[n(%)]表示,用 χ^2 检验。 $P < 0.05$ 表示有统计学意义。

2 结果

2.1 两组治疗效果对比 研究组的治疗有效率高于常规组($P < 0.05$),见表1。

表1 两组治疗效果比较 [n(%)]

组别	例数	治愈	显效	有效	无效	有效率
研究组	40	16(40.00)	18(45.00)	6(15.00)	0(0.00)	40(100.00)
常规组	40	8(20.00)	17(42.50)	10(25.00)	5(12.50)	35(87.50)
χ^2						5.333
P						0.021

2.2 两组中医证候评分对比 治疗后,研究组的腹痛、嗝气、泛吐酸水、少食、倦怠乏力等症状评分均低于常规组($P < 0.05$),见表2。

表2 两组中医证候评分比较 ($\bar{x} \pm s$,分)

组别	例数	腹痛		少食		倦怠乏力		泛吐酸水		嗝气	
		治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
研究组	40	2.67 ± 0.43	0.61 ± 0.10	2.45 ± 0.34	0.44 ± 0.02	2.28 ± 0.56	0.31 ± 0.02	2.58 ± 0.44	0.56 ± 0.16	1.65 ± 0.48	0.10 ± 0.05
常规组	40	2.64 ± 0.33	1.06 ± 0.42	2.53 ± 0.40	1.23 ± 0.30	2.34 ± 0.47	1.16 ± 0.39	2.55 ± 0.65	0.93 ± 0.23	1.62 ± 0.30	0.44 ± 0.18
t		0.350	6.592	0.964	16.618	0.519	13.766	0.242	8.352	0.335	11.511
P		0.727	0.000	0.338	0.000	0.605	0.000	0.810	0.000	0.738	0.000

3 讨论

消化性溃疡主要发生在胃、十二指肠及食管上段,由于各种原因造成的消化道黏膜局部缺损。消化性溃疡是一种常见的消化系统疾病,常表现为黏膜破坏、溃疡及其他病理改变。消化性溃疡主要表现为上腹疼痛,常在饭后或空腹时加重。疼痛可表现为钝痛,灼热或尖锐的疼痛,并伴有恶心、呕吐、食欲下降等症状。如果病情严重,患者可能会有消化道出血的症状,如解黑便或呕血^[4,5]。四联疗法是一种常用的治疗消化性溃疡的方法,通常包括质子泵抑制剂、两种抗生素以及铋剂。然而,对于一些慢性或复杂的病例,四联疗法的疗效可能不尽如人意^[6]。因此,采用中药进行消化性溃疡的治疗变得尤为重要。香砂平胃颗粒是一种常用的中成药,主要用于治疗消化系统疾病,特别是在消化性溃疡的治疗中展现出一定的优势。该药由多种中药材精制而成,主要包括砂仁、木香、苍术、厚朴等

成分,其中苍术燥湿、健脾止泻,陈皮理气健脾,燥湿化痰,厚朴行气宽中,燥湿除胀,香附理气止痛,砂仁化湿醒脾和胃,甘草补中益气,调和诸药,诸药合用,共奏健脾和胃、理气消胀的功效^[7],该药物能够通过调节脾胃功能、促进消化液分泌、增强胃黏膜屏障功能等多种途径发挥作用,从而有助于减轻消化性溃疡引起的疼痛、不适等症状^[8]。

本研究中,治疗后,研究组的治疗有效率、中医证候积分、胃肠激素水平等均优于常规组($P < 0.05$),表明香砂平胃颗粒辅助治疗消化性溃疡具有较高的有效性和安全性。分析原因:香砂平胃颗粒是一种中药制剂,主要用于调理胃部和理气,具有促进气血流通和消除滞气的效果,该药物能够全面改善脾胃的功能,从而增强人体的自我修复能力^[9]。这种全方位的调理特性不仅能够有效缓解症状,还能提升患者的整体健康水平^[10]。在改善中医证候积分方面,香砂平胃颗粒强调辨证施治的原则,能够有效地提升中医证候积分^[11]。这种方法重视个体差异,根据每位患者的具体症状进行个性化调整,通常能够取得更为理想的临床效果,并有助于降低症状复发的风险^[12-15]。

综上所述,在消化性溃疡的辅助治疗中,采用中西医结合治疗的优势显著,有助于促进病情恢复,推荐应用。

参考文献

- [1]陈娟,康靖东,谢慧梁,等.中西医结合治疗消化性溃疡(肝胃不和和证)的疗效观察[J].中国中医急症,2024,33(7):1215—1217.
- [2]郭少勇.聚普瑞锌联合奥美拉唑治疗消化性溃疡导致的上消化道出血的临床价值研究[J].系统医学,2024,9(11):80—83.
- [3]陈令媛.康复新液联合雷贝拉唑肠溶片治疗消化性溃疡临床治疗效果[J].内蒙古中医药,2024,43(5):24—26.
- [4]周小琳,王旭.中医内科学[M].中国医药科技出版社,2022.
- [5]谢晓义.康复新液联合埃索美拉唑治疗消化性溃疡的临床效果[J].临床合理用药,2024,17(13):68—70.
- [6]陈云香,陈志鹏.香砂平胃颗粒辅助治疗消化性溃疡患者的疗效及对中医证候积分、胃肠激素水平的影响[J].医学理论与实践,2024,37(7):1137—1139.
- [7]兰忠兴,陈志鹏,陈妙生.三联疗法联合香砂平胃颗粒治疗幽门螺杆菌阳性消化性溃疡的临床效果分析[J].中外医疗,2023,42(27):9—12.
- [8]陆贤香,陆文瑜,周静.胃苏颗粒联合四联疗法治疗Hp阳性消化性溃疡的临床效果观察[J].中外医学研究,2021,19(29):22—24.
- [9]谢明山,肖义琼,蓝志伟.胃苏颗粒联合四联疗法对Hp相关性消化性溃疡疗效与炎症因子水平的影响[J].医学理论与实践,2021,34(19):3367—3368.
- [10]胡荣,宋婷,刘静静,等.胃苏颗粒联合四联疗法对幽门螺杆菌相关性消化性溃疡患者血清炎症因子、胃肠激素及生活质量的影响[J].现代生物医学进展,2021,21(14):2675—2678,2707.
- [11]孟小虎.胃苏颗粒联合四联疗法治疗幽门螺杆菌相关性消化性溃疡的临床效果分析[J].黑龙江科学,2021,12(14):64—65.

- [12]秦艳辉.胃苏颗粒联合四联疗法在幽门螺杆菌感染性胃溃疡中的应用效果分析[J].中国烧伤创疡杂志,2021,33(3):225—228.
- [13]黄钟燕,罗锐.胆胃宁颗粒联合奥美拉唑肠溶片治疗湿热中阻型胃溃疡的效果及对HP根除率、不良反应的影响[J].解放军医药杂志,2021,33(04):65—69.

- [14]倪衍平.胃力康颗粒对胃溃疡大鼠炎症因子表达的影响[J].吉林医学,2021,42(2):265—266.
- [15]王伟,路士华,王建波,等.胃舒颗粒联合耳穴压豆治疗肝郁脾虚型十二指肠溃疡的临床研究[J].中华中医药杂志,2020,35(11):5895—5898.

温通养心汤联合曲美他嗪对老年心力衰竭患者心功能的改善效果

王建霞¹ 张明霞¹ 齐如艳²

(1.北京市第一中西医结合医院老年病科 北京 100018;2.北京市第一中西医结合医院检验科 北京 100018)

[摘要] **目的:**探究温通养心汤联合曲美他嗪对老年心力衰竭患者心功能的影响。**方法:**选取2022年6月—2024年6月期间我院92例心力衰竭老年患者进行前瞻性试验,随机分为对照组、观察组各46例。对照组用曲美他嗪治疗,观察组用温通养心汤联合曲美他嗪治疗。**结果:**两组基线资料无显著差异($P>0.05$)。观察组总有效率高于对照组($P<0.05$)。治疗后,观察组超声心动图、心肌纤维、TLR4/NF- κ B信号通路指标水平更低($P<0.05$)。观察组不良反应发生率较低($P<0.05$)。**结论:**温通养心汤可改善老年心力衰竭患者心功能,降低相关指标水平,提升疗效且不良反应少。

[关键词] 温通养心汤;曲美他嗪;老年;心力衰竭;心功能

中图分类号: R541.6

文献标识码: B

文章编号: 1006-0979(2025)07-0015-03

心力衰竭作为心脏病的终末阶段,因心脏组织结构和功能的病理性变化导致心室射血功能障碍,临床表现为四肢水肿、呼吸困难等症状,影响患者生活质量;临床上常用西药治疗,以曲美他嗪为代表,其通过抑制心肌脂肪酸表达,提高心肌代谢效率,改善心肌射血功能^[1]。然而,对于老年患者, β 受体阻滞剂和血管紧张素的效果有限,5年死亡率仍然较高;近年来,中医疗法在心力衰竭治疗中显示出优势,中西医结合能有效改善症状^[2]。温通养心汤作为一种中药汤剂,可活血益气,调节心脏功能^[3]。本研究旨在分析温通养心汤联合曲美他嗪对老年心力衰竭患者心功能的改善作用,以期提高疗效并补充临床治疗方案。具体如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2022年6月—2024年6月期间在我院诊治的患心力衰竭的92例老年患者进行前瞻性试验,随机均分为对照组和观察组,每组46例。其中,对照组男性28例、女性18例;平均年龄、体重指数及病程为(69.88 ± 5.85)岁、(22.54 ± 1.93) kg/m²、(4.11 ± 0.57)年;NYHA心功能Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级分别为21、18、7例;房颤5例;冠心病、高血压性心脏病、其他分别为24、10、12例。观察组中男性30例、女性16例;平均年龄、体重指数、病程为(71.04 ± 5.71)岁、(23.07 ± 1.89) kg/m²、(3.96 ± 0.47)年;NYHA心功能Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级分别为23、20、3例;房颤6例;冠心病、高血压性心脏病、其他分别为26、8、12例;基本资料差异不突出($P>0.05$),有可比性。本试验已通过医院伦理委员会的审核批准。

诊断标准: (1)西医标准:符合心力衰竭诊断文献^[4]; (2)中医评判准则:符合心肾阳虚辨证的相关文献^[5],以及主、次症状。

纳入标准: (1)符合以上评判准则; (2)实验室确诊为心力衰

竭;(3)NYHA为Ⅱ~Ⅳ级^[6]; (4)年龄 ≥ 60 岁; (5)签署知情同意书。

排除标准: (1)对研究药物过敏; (2)肝肾功能障碍; (3)合并恶性肿瘤; (4)心源性休克史; (5)配合度低。

1.2 方法 对照组患者接受常规治疗,包括卧床休息,日常锻炼以及保持良好情绪等。给予吸氧和盐酸曲美他嗪片(湖北四环制药,国药准字H20093596,20 mg/片)口服,每次一片,每日三次。

观察组:在对照组治疗基础上加用温通养心汤,成分包括人参、当归、炙甘草各12 g,丹参、黄芪各15 g,茯苓、川芎、桂枝、泽兰各10 g,白术9 g。药物加水熬制,患者每日服用两次,共一剂。

患者均进行为期1个月的疗程。

1.3 观察指标 (1)疗效:治疗效果依据中医诊断与治疗指南文献^[7]评估。显效:指症状完全消失,中医证候积分减少超过70%,NYHA级别提升2级或更多;有效指证候积分减少超过30%,NYHA级别提升至少1级;无效则是证候积分减少不足30%,NYHA级别下降或恶化。总有效率为显效与有效的总和。(2)超声心动图指标:治疗前后,使用彩色超声诊断仪(大卫医疗,型号:DT-3)测定患者的LVEDD、LVESD,操作按仪器说明书进行。(3)心肌纤维指标:治疗前后,收集患者空腹肘静脉血3 ml,以2900 r/min离心13分钟,直径11 cm。测定上清液中NT-pro BNP、TGF- β 1、CTGF水平,采用酶联免疫吸附试验,按说明书操作。(4)TLR4/NF- κ B信号通路指标:治疗前后,收集患者空腹肘静脉血3 ml,以2900 r/min离心13分钟后,采用ELISA法评估上清液中TLR4、NF- κ B含量,操作按说明书进行。(5)不良反应:统计2组发生的嗜睡、呕吐等情况。

1.4 统计学分析 通过SPSS 27.0进行分析,计量资料采用($\bar{x} \pm s$)表示,用 t 检验;计数资料采用[n(%)]表示,用 χ^2 检验。 $P<0.05$ 表示有统计学意义。

作者简介:王建霞(1986—),女,本科,主治医师,研究方向,中西医结合老年病。